

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	小兒存留導尿評核表	編號	A31000-Q06-F-D11
			版本	第 2.6 版
	制定 單位	護理部	修正日期	114 年 12 月 15 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：兒科護理人員。

二、評核方式：口述或實際操作。

三、評核內容：

1. a. 時機 1 接觸病人前洗手
b. 選擇適合的導尿管，女病童：採屈膝仰臥的姿勢；男病童：採仰臥的姿勢。
註：檢視導尿包完整及有效期限，嬰兒：3Fr.導尿管或（5Fr.鼻胃管代替）兒童：8～10Fr. 青少年：12～14Fr.。
2. a. 時機 3 暴露病人體液風險後 & 時機 2 執行無菌技術前洗手
b. 會陰沖洗
c. 以無菌技術打開拋棄式導尿包，將導尿包外包布墊在病童臀下
d. 將導尿管由內包裝取出接上蓄尿袋或精密尿筒的接口。
e. 將優碘及蒸餾水倒在雙格消毒液盒中棉棒上，並將水溶性潤滑劑擠在無菌紗布上潤滑導尿管頭部 2～4 吋（約 5～10 公分）。
f. 戴上無菌手套，將無菌洞巾鋪於病童會陰部。
註：女病童的固定方法：一手的食指和大拇指分開小陰唇，男病童的固定方法：一手握住陰莖，將包皮往後推。
3. a. 女病童的消毒法：以優碘第一支棉棒由上往下擦拭遠側小陰唇，第二支棉棒由上往下擦拭近側小陰唇，第三支棉棒由上往下擦拭尿道口，再用蒸餾水棉棒，依上述的方式消毒。男病童的消毒法：以優碘由尿道口起，環形方式擦拭，再用蒸餾水棉棒，依上述的方式消毒。
b. 請病童張口哈氣或做深呼吸，將導尿管插入尿道口：女病童：插入 1～2 吋（2.5～5 公分），或尿液流出。男病童：將陰莖豎立成 90 度，插入 2～3 吋（5～5.7 公分），或尿液流出。
c. 固定導尿管並打入 5～10 c.c. 的蒸餾水至導尿管的氣囊內，輕拉回導尿管，確定導尿管已固定。（不可回推）
d. 脫除無菌手套，進行時機 3 暴露病人體液風險後洗手。
e. 以紙膠、膠布、Tegaderm 或 mefix 固定導尿管於病童大腿內側：女病童：大腿內側上 1/3，男病童：下腹部或大腿前側，於蓄尿袋或精密尿筒上註明日期。
註： 1. 以鼻胃管代替尿管不須導尿管打入蒸餾水此過程。
2. 嬰兒則以 Tegaderm 固定於會陰，再以紙膠固定於大腿內側上 1/3 或下腹部或大腿前側。
4. a. 評估病患有不適之主訴(如：疼痛、發燒)及蓄尿袋內或精密尿筒尿液之性質(如：尿量減少、顏色混濁或呈血色、惡臭)。
b. 離開病房後，進行時機 4 接觸病人後洗手。
c. 記錄內容包括：導尿的時間，尿量、尿液顏色、性質及病童導尿反應

